心知 / 阅读与研讨

心知 · 网站使用说明手册

心血管 × AI 医疗文献学习站

网站：https://learn.dryz.info/

适用对象：日常阅读、文献查新及晨会准备的用户。

手册版本：1.1 ｜ 编制日期：2026 年 10 月 10 日（北京时间）。

格式：Markdown、HTML、PDF，三种格式正文一致。

> 本手册从 2026-10-07 对话中的完整正文恢复，并于 2026-10-10 对齐主分支 f3e0ff8。原截图文件未保存在本工作区，本版六张截图重新取自当前本地公开包预览；接口可用性采用关闭生成的模拟响应，不代表线上鉴权、全文任务或当前数据已验收。网站状态以实际显示和运行记录为准。

目录

1. 快速上手
2. 认识网站与内容标记
3. 每日精选：从导读开始
4. 文献雷达与文献库：检索、筛选和关注
5. 阅读台：摘要、原文与引用
6. AI 辅助阅读：翻译、速览与研究结构
7. 本周精读：榜单、正式期次与示范
8. 晨会清单：收集、对照、分享与导出
9. 手机使用、界面风格与快捷键
10. 信源状态与内容更新时间
11. 常见问题与处理方法
12. 三个使用场景与手册文件说明

1. 快速上手

1.1 第一次访问

1. 用浏览器打开 learn.dryz.info。公开阅读页面无需登录；首次加载请等待文献列表出现。
2. 首页进入“每日精选”。先看内容标记和日期，再选择一篇感兴趣的文献。
3. 点击“阅读导读与摘要”“阅读 AI 速览”或“阅读摘要”，打开右侧阅读台。
4. 先读中文导读或速览，再核对“公开摘要 · 原文”；需要全文时点击“前往官方原文”。
5. 有讨论价值的文献点击“加入晨会单”。打开右上方“晨会清单”，可复制汇总或导出 Markdown。

建议阅读顺序：选栏目 → 看标记 → 读原摘要 → 留晨会单 → 打开官方原文。

1.2 按目的选入口

你想做什么	从哪里开始	接下来怎么做
快速看近期值得关注的文章	每日精选	读导读，核对原摘要
查某个主题的新文献	文献雷达	选时间范围，输入关键词
查已有收录的旧文献	文献库	选“全部时间”，按题名、DOI 或 PMID 检索
准备一次文献研讨	晨会清单	从各栏目收集文献，再复制或导出
查看完整的精读报告	本周精读	先确认本周发布状态，再选期次

使用前知道两件事：网站帮助学习与查新；AI 结果、自动标签和引用草稿都需要回查来源。个人晨会清单与关注期刊保存在当前浏览器，暂不跨设备同步。

2. 认识网站与内容标记

2.1 页面主要区域

顶部是四个栏目、搜索框、界面风格、深浅色切换和晨会清单。栏目下方显示不同内容的更新时间。文献雷达与文献库还提供分类、时间范围、期刊和可读内容筛选；桌面端左侧有进一步筛选条件。内容区右上方有独立的“信源状态”入口。

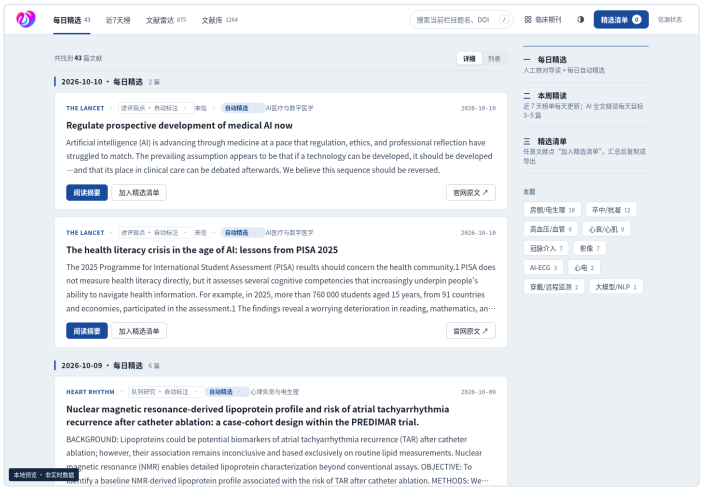


图 1：本地预览首页，用于定位导航、搜索和晨会清单；截图中的日期与数量不代表实时数据。

2.2 先认清标记，再判断阅读深度

页面标记或内容	表示什么	阅读时如何使用
题录 / 自动聚合	题名、期刊、日期、DOI 等基础资料	用于发现文章，不表示已读全文
公开摘要 · 原文	来源数据库或期刊的公开摘要	作为核对导读、译文与 AI 要点的依据
机器翻译	模型生成的中文题名或摘要对照	术语、数字及结论回查英文原文
AI 速览 / 自动精选	AI 辅助速读或规则选出的文章	未经人工核验，不等于全文精读
摘要核对导读	已按标注范围核对公开摘要的中文导读	核对范围限于摘要，未经医生终审
全文精读	明确基于已取得全文编写的报告	查看期次、来源和审查范围；医生终审状态另看说明

“研究设计 · 自动判断”“研究类型待核验”、样本规模和效应量等自动提取信息用于辅助浏览。它们可能有误，不能代替论文方法和结果部分。“推荐”排序与榜单序号也不代表研究质量等级。

3. 每日精选：从导读开始

3.1 阅读一篇精选

1. 点击顶部“每日精选”。文章按精选或导读发布日期分组；分组日期可能不同于论文发表日期。
2. 用主题按钮缩小范围，或在顶部输入关键词。
3. 查看卡片上的期刊、研究设计、日期及“摘要核对”“自动精选”等标记。
4. 点击卡片的阅读按钮。已有导读时，阅读台会显示中文核心导读、证据边界和共读问题；具体内容以该篇实际提供的字段为准。
5. 向下查看原摘要；需要完整方法、图表和附录时打开官方原文。

3.2 分享与保存

有导读的文章可通过卡片“微信群文案”或阅读台“复制微信群文案”复制分享文字。复制后自行粘贴到微信或其他交流工具，网站不会自动发送消息。

“加入晨会单”适合暂存准备讨论的文章；保存的是当前浏览器中的文献清单，不是全文文件。再次点击已加入的按钮可取消，或在清单中点击“移出”。

3.3 没看到今天的新导读

自动查新、规则精选、AI 速览和摘要核对导读有各自的更新时间。查新更新不表示当天一定有新的人工核对导读。请看页面日期与内容标记，不把历史导读当成当天完成的精读。

4. 文献雷达与文献库：检索、筛选和关注

4.1 两个栏目如何选择

项目	文献雷达	文献库
主要用途	追踪新文献及较近的历史题录	检索网站既有收录范围
时间选择	近 7 / 14 / 30 / 90 / 365 天	全部时间、近 30 / 90 / 365 天
初始范围	默认近 14 天	默认全部时间
阅读内容	摘要、导读或 AI 速览按实际可用情况显示	题录及可取得的公开摘要，不提供私人全文 PDF

较早的雷达条目主要来自关注期刊的 PubMed 题录，通常要打开阅读台后再尝试获取摘要。365 天视图不代表覆盖所有来源、所有文章或所有全文。

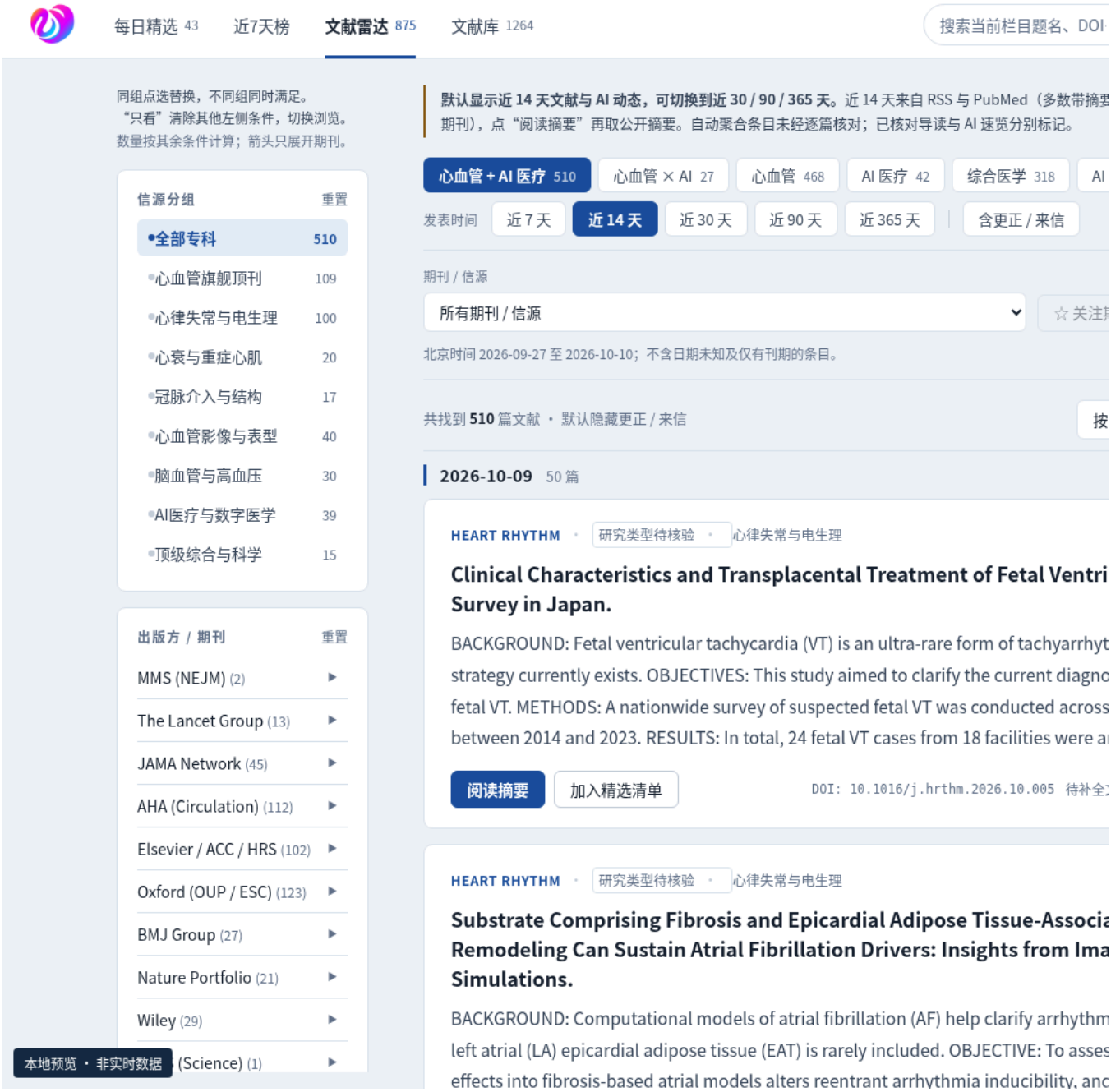


图 2：本地预览的雷达界面；分类、时间、期刊和可读内容条件可以叠加。

4.2 搜索关键词

顶部搜索框对当前栏目及现有筛选范围内的文献进行检索。可输入中文关键词、英文题名片段、作者、期刊、DOI 或 PMID；只有已收录的字段能被命中。

- 查主题：输入 `房颤消融` 、 `心衰` 、 `大模型` 。

- 查组合：输入 `房颤 消融`；以空格分隔的词需要同时匹配。
- 查具体论文：粘贴 DOI 编号，例如 `10.1038/s41591-025-03517-w`，或输入 PMID 数字。

中文检索会对部分医学词汇作英文扩展，但不是自然语言问答。若结果少，尝试英文关键词或较短词组。DOI 建议只粘贴编号，去掉网址前缀。

4.3 逐步筛选

1. 先选分类，例如“心血管 × AI”“心血管”“AI 医疗”或“全部”。默认的“心血管 + AI 医疗”并非所有来源。
2. 选择发表时间范围。“近 7 天”等按北京时间计算；只有刊期月份、缺少确切日期的条目可能不进入按天筛选。
3. 在“期刊 / 信源”下拉框选择来源。
4. 在“可读内容”中选“有公开摘要”“已核对导读”或“AI 速览（未核对）”。“有公开摘要”依据当前已有数据筛选，未显示的文章也可能在打开后取得摘要。
5. 需要时使用左侧“信源分组”“按出版方浏览”“研究设计”“主题标签”。手机端先点“筛选”。

结果为空时，依次清空搜索词、放宽分类与时间、取消期刊和“我的期刊”、将可读内容改为“全部”，再重置左侧条件。切换栏目后也应检查是否仍有其他筛选条件。

4.4 关注期刊、排序和显示更多

选择具体期刊后点击“☆ 关注期刊”。点击“我的期刊”仅查看自己关注的期刊，再次点击可取消限制。关注列表只存在当前浏览器，不会同步到同事或另一台设备。

排序可选“最新在前”“最早在前”“按期刊分组”或“推荐（导读/摘要优先）”。“详细”显示完整卡片，“列表”适合快速扫读；结果较多时点击页面下方“显示更多”。更正、来信等默认隐藏，可用“含更正 / 来信”按钮查看。

筛选后可以复制地址栏链接分享检索视图。链接不包含你的关注列表或晨会清单；若分享时开启了“我的期刊”，接收者的结果仍受其自己的关注列表影响，建议先关闭该条件。

4.6 筛选与切换浏览（v14.3.1）

- 左侧各模块单选，同组点击新选项替换原选项，再次点击已选项保持选择；不同模块的条件需同时满足。例如选 Circulation 再选 RCT，会显示 Circulation 中的 RCT。
- 已有其他左侧条件时，选项旁会出现“只看”。点击“只看 RCT”会移除信源分组、期刊和主题等其他左侧条件，只保留 RCT；顶部领域、时间、关键词、可读内容及“我的期刊”条件保留。
- 出版方名称用于筛选该出版方，右侧箭头只展开或收起旗下期刊。顶部期刊下拉框与左侧期刊共享选择；换到另一出版方的期刊会同步更新所属出版方。
- 结果上方显示“当前筛选 · 同时满足”。点一个条件的 × 只移除该维度；期刊与出版方属于同一维度，清除期刊不会暗中保留出版方。“清空左侧筛选”保留顶部条件；“重置所有条件”恢复默认范围并清除关键词。
- 选项数量按其他条件计算，表示替换本组选项后的匹配篇数。零匹配选项仍可用“只看”切换浏览。组合无结果时，页面提供保留其中一项的实际篇数和按钮，不自动放宽条件。

5. 阅读台：摘要、原文与引用

5.1 打开和关闭

在文献卡片或列表行中点击阅读按钮，右侧打开“文献阅读台”。关闭可点击右上角“×”、背景遮罩或按 `Esc`；手机上阅读台会占据更大屏幕区域。



图 3：本地预览的阅读台；内部可继续向下滚动，底部有晨会单与官方原文入口。

5.2 推荐阅读顺序

1. **确认论文身份。**核对英文题名、期刊、发表日期、DOI / PMID；中文题名可能是机器翻译。
2. **读已有导读或速览。**看研究问题、主要发现和标注的局限。
3. **看“公开摘要 · 原文”。**结构化摘要可能按背景、方法、结果等分段；未取得摘要时页面会说明原因。
4. **核对关键数字。**“摘要自动提取的数字”可以展开，样本数、随访、效应量及显著性须与原摘要核对。
5. **打开官方原文。**需要全文、图表、补充材料或判断研究质量时，继续前往期刊或 PubMed。

“阅读这类研究要看什么”是按研究类型提供的通用阅读提示，不是对该篇论文已经完成的质量评价。

5.3 原文与引用草稿

阅读台底部有“前往官方原文”。题录区域还可能显示“DOI”“PubMed”入口。外部期刊全文可能需要机构订阅或个人权限；网站不公开私人 PDF。

在“题录引用草稿与原文入口”中可复制 GB/T 引用草稿、AMA 引用草稿或 BibTeX 题录。它们由已有字段生成，正式使用前应补全并核对作者、卷期、页码、文章号和 DOI；缺少字段不代表论文没有该信息。

5.6 全文下载与 Muse 协同

已有可用全文时，输入既有全文口令下载。缺全文时在任务页提交 DOI，由 Muse 使用开放来源或已授权的汉堡浏览器获取原件。流程经过下载、私有 Drive 上传、网站回传、独立核验后才开放下载；“已上传”或“待核验”不等于已可下载。失败时按页面原因处理，恢复入口仍需全文口令。口令只填网站表单。

Muse 下载端定时任务在本次对话记录中尚未创建，不承诺提交后会无人值守领取。网站核验已有定时成功运行记录；GitHub 实际调度可能明显延迟。网站可下载不代表 Mac/GitHub/正式 Drive 三端归档完成。

6. AI 辅助阅读：翻译、速览与研究结构

6.1 摘要翻译与一键解读

当相应服务开放且文献有可用标识时，页面会显示 AI 操作入口。

操作	在哪里点击	得到什么
翻译摘要（中英对照）	阅读台“公开摘要 · 原文”下方	与原摘要对照的中文译文
一键 AI 解读	尚无导读或速览的文献阅读台	基于公开摘要的中文速览及原句依据
只翻译标题	部分未找到摘要的文献阅读台	中文题名，不生成研究结论
AI 综述本页前 N 篇	当前文献结果上方，符合条件时显示	当前排序靠前、具有 PMID / DOI 的最多 8 篇的摘要速读

点击生成后等待页面完成或显示错误，避免连续重复点击。页面估时通常为十几至几十秒，来源获取和服务状态可能使等待更长。已有结果可被其他读者复用，不代表已经人工核对。

这些功能处理公开题名与摘要。它们不代表读取了论文全文，也不是患者问题问答入口。AI 综述只处理当前结果中的部分文章，不等于对检索结果做了系统综述。

6.2 研究结构与全文核对（新增入口）

仅在阅读台出现“研究结构与全文核对”区域后使用。若当前线上页面没有该区域，可继续使用原摘要、阅读提示和官方原文入口。

1. 打开目标文献阅读台，滚动到“研究结构与全文核对”。页面先检查已有结果；这一步不会调用模型生成。
2. 有已有结果时直接阅读。若显示“提取研究结构与核对清单”，点击后才开始生成。
3. 逐项查看研究问题、研究对象、研究设计、干预与对照、研究终点、主要结果。
4. 展开“核对摘要原句”，确认各项中文内容对应的英文依据；查看摘要来源与生成时间。
5. 展开“全文核对清单（待查事项）”，带着问题阅读全文；可点击“复制研究结构与核对清单”保存。

“摘要未提供”表示该信息未在摘要中找到，不能理解为研究没有设置该环节。全文核对清单是待确认的问题，不能据此认定论文已经存在这些缺陷。原试验为 RCT，也不意味着其事后分析仍是新的随机试验。

6.3 生成失败或按钮不显示

按钮是否显示取决于上线版本、服务开放状态、文献标识及已有结果。无公开摘要时可能不生成；额度用尽、网络故障、服务配置或结果校验失败时也会停止。

按页面提示处理即可：稍后重试、次日再试或反馈维护者。结果提示“未保存”时不要把失败状态当成可用内容；仍可阅读已经取得的原摘要并打开官方原文。

7. 本周精读：榜单、正式期次与示范

7.1 先看本周发布状态

点击顶部“本周精读”，先读页面顶部的本周日期和发布状态。若写“全文精读尚未发布”，表示本周没有正式的新精读报告；下方榜单或旧示范不代表本周已经完成全文审查。



图 4：本地预览的精读栏目；请区分本周状态、规则榜单与历史体例示范。

7.2 三类内容分别使用

区域	作用	使用方法
近 7 天文献榜	根据相关性、研究类型、期刊等规则帮助选题	读已取得的原摘要；AI 速览另看标记
精读期次	按期查看已发布的报告	核对期次日期与审查范围
全文精读体例示范	展示报告的写法和阅读结构	点击展开，按背景、AI 环节、设计、结果及局限阅读

榜单属于选题辅助，不是文献质量排名。“摘要待补充”表示当前尚未取得该摘要。示范论文的原始发表年和示范发布日期可能不同，应分别阅读标注。

有“下期候选”时，可点击“加入晨会单”表达讨论兴趣；进入候选不代表已经选定、已经评审或即将按固定日期发布。

7.4 每日 AI 全文精读

现有 GitHub Actions 每天北京时间 05:17 计划完整刷新，默认新增 4 篇、目标 3–5 篇；每两小时轻量刷新读取缓存。只使用可公开获取并核对身份的全文，显示实际日期、完成数量及不足原因。标记为“AI 全文精读 · 未经人工审核”，与历史示范或人工审核稿分开；目标不是每日完成保证。

8. 晨会清单：收集、对照、分享与导出

8.1 收集与管理文献

1. 在卡片、列表、阅读台或下期候选中点击“加入晨会单”。顶部计数随选择变化。
2. 点击右上方“晨会清单”，查看已加入文章的题名、期刊、研究设计与日期。
3. 不需要的文章点击“移出”；点击“清空清单”会立即移除当前全部选择，使用前建议先复制或导出。

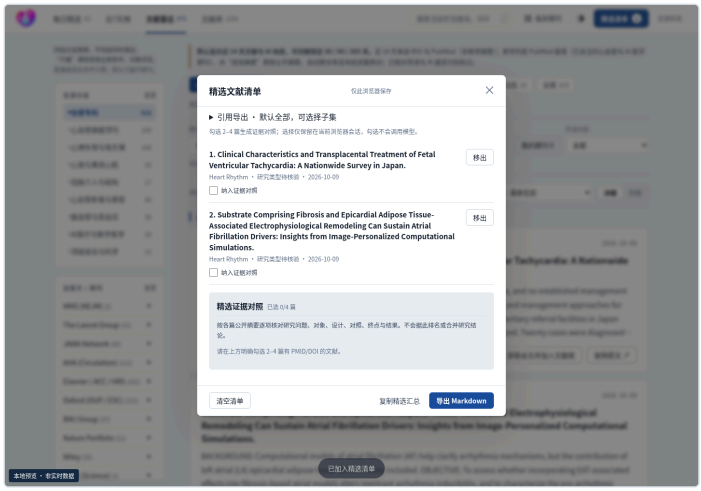


图 5：本地预览的清单；新版勾选框用于证据对照，底部用于复制汇总和导出。

8.2 复制汇总和导出 Markdown

- **复制晨会汇总：**点击后把文献列表和原文链接复制到剪贴板，再自行粘贴到群聊、邮件或笔记。
- **导出 Markdown：**清单非空时点击，下载 `晨会文献清单-YYYY-MM-DD.md`；文件日期按北京时间生成。

导出包括已有题录、导读或摘要概要及相应证据边界、问题等字段，具体内容取决于该篇已经保存的数据。**常规清单导出不自动包含新生成的研究结构、证据对照表、摘要译文或 AI 讨论提纲。**这些内容需要用各自的复制按钮或手动选中保存；导出前建议打开文件检查实际内容。

8.3 AI 讨论提纲

清单中有至少 2 篇具有 PMID / DOI 的文献且 AI 服务开放时，可能显示“AI 生成讨论提纲”。点击后，系统按清单中符合条件的最多 8 篇公开摘要整理主题、逐篇要点、共同点与分歧及讨论问题。

讨论提纲未经人工核对，用于组织讨论。清单很多时不会一次处理全部文章；可先整理清单，再点击生成。

8.4 逐篇证据对照（新增入口）

仅在清单中出现“纳入证据对照”勾选框和“晨会证据对照”区域后使用。

1. 先把目标文章加入清单，再明确勾选 2–4 篇有 PMID / DOI 的文献。勾选仅选中文献，不会调用模型生成。
2. 页面先读取这一组的已有结果；需要生成时点击“生成所选 N 篇证据对照”。
3. 逐列查看每篇的研究问题、对象、设计、干预与对照、终点、主要结果及摘要来源。
4. 展开各单元格“核对摘要原句”。手机端可横向滚动表格；没有摘要的文章会保留并说明原因。
5. 点击“复制证据对照与核对清单”，另行保存到研讨笔记。

不能重复选择同一论文；缺少标识的文章不能勾选。对照只并列展示各篇摘要证据，不做研究质量排名，不合并效应量，也不证明不同研究之间可以直接比较。

8.5 保存范围

晨会清单保存在当前浏览器；证据对照的勾选仅保留在当前页面会话。更换设备、浏览器、使用无痕窗口或清理网站数据后，个人设置或清单可能不可见。需要交接给同事时，复制或导出具体材料。

9. 手机使用、界面风格与快捷键

9.1 手机上筛选与阅读

用手机浏览器直接访问同一网址。进入雷达或文献库，点击“筛选”打开筛选面板，选择条件后点击“完成”回到结果。阅读台与晨会清单可上下滚动；多篇证据表可左右滚动。



图 6：390 像素宽的本地手机预览；“完成”关闭筛选面板。

9.2 调整阅读外观

顶部界面风格按钮可能显示当前风格名称。点击后可选择“临床期刊”“资讯榜单”“卡片杂志”或“纸感”。旁边的深浅色按钮切换深色与浅色；“详细 / 列表”调整文献显示密度。这些设置会尽可能记住在当前浏览器中，外观不同不改变文献的核对状态。

9.3 桌面快捷操作

操作	方法
快速进入网站搜索	按 `/`
关闭阅读台、晨会清单或筛选面板	按 `Esc`
用键盘逐个访问控件	按 `Tab`，反向用 `Shift + Tab`
在本手册中查找文字	Windows / Linux 按 `Ctrl + F`，Mac 按 `Command + F`

10. 信源状态与内容更新时间

10.1 查看更新时间

顶部更新时间分别反映查新、摘要核对导读、AI 速览等内容。应看对应项目的日期，不能仅根据页面刷新或网站能打开就判断每个栏目都是最新。

当前运营说明的计划为：每 2 小时轻量查新，每日北京时间 05:17 进行较完整的补充处理。实际任务可能延迟或失败，计划时间不保证当天一定产生新导读、成功的 AI 结果或新的全文精读；普通用户以页面记录为准。

10.2 看懂“信源状态”

点击内容区右上方“信源状态”，查看最近一次自动检查的时间、来源和抓取状态。返回主栏目可继续阅读。

状态	如何理解
获取成功	本次成功取得该来源数据
有效空源 / 近 14 天无新条目	获取成功但没有符合范围的新文章，不一定是故障
返回非订阅内容 / 订阅格式异常	来源响应与订阅格式不符，需要维护者排查
来源 HTTP 错误 / 获取异常	本次来源请求失败，不表示整个网站不可用
保留旧缓存	当前可能仍展示之前取得的有效资料，注意缓存日期
报告已过期	不能据旧报告判断当前来源是否可用

来源抓取正常不代表文章质量更高，也不代表 AI 服务正常。普通用户遇到问题可记录来源名称、时间和页面提示，反馈维护者。

11. 常见问题与处理方法

11.1 检索与阅读

现象	处理方法
搜索没有结果	先清空其他筛选，关闭“我的期刊”，扩大时间与分类；再试英文关键词、DOI 或 PMID。网站检索限于已收录资料
卡片有题名，阅读台没有摘要	等待来源获取；若提示未收录或获取失败，稍后重开或查看官方原文。题录存在不保证摘要或全文可用
没有更多文章显示	检查筛选条件和结果总数；页面底部有“显示更多”时继续加载
官方全文要求登录或付费	使用机构订阅、个人权限或论文公开版本；站内公开题录不包含全文访问权限
中文题名、研究类型或数字可疑	对照英文摘要和官方原文；标记为机器翻译或自动判断的内容可能有误
引用没有作者、卷期或页码	这是题录草稿，正式引用前从原文补全字段

11.2 AI 生成与个人设置

页面现象或提示	建议操作
AI 按钮没有出现	确认是否存在相应功能区域和 PMID / DOI；功能也可能尚未上线或服务未开放
没找到公开摘要	直接读官方原文；若有“只翻译标题”可使用，但不会生成研究结论
正在生成 / 这篇正在被生成	等待后再查看，避免重复连续点击
今日额度或个人次数已达上限	阅读已有结果，按页面提示稍后或次日再试；服务额度日可能按 UTC 计算，与北京时间零点不同
网络错误、响应超时、暂时限流	稍后重试；持续失败时记录原文标识、操作时间及完整提示
服务认证失败、尚未配置或功能未开放	反馈维护者，普通用户无需更改服务配置
译文漏数、引文不符或格式校验失败	本次结果未保存；回查原摘要，必要时重试或反馈具体论文
换设备后关注或晨会单不见了	这些个人数据只存当前浏览器，使用复制或导出材料交接
复制或下载后没有找到内容	查看浏览器剪贴板权限与下载记录；可选中文本手动复制，导出前确认清单非空

11.3 向维护者反馈

建议一次写清：发生时间（北京时间）、设备与浏览器、所在栏目、论文题名及 DOI / PMID、点击的按钮、完整错误提示，以及脱敏截图。不要发送账号密码、密钥或患者资料。

可用格式：`2026-10-07 16:30，手机浏览器，文献雷达，PMID：……，点击“翻译摘要（中英对照）”后显示“……”。`

12. 三个使用场景与手册文件说明

12.1 查“房颤消融”近一周新文献

1. 进入“文献雷达”，选择“近 7 天”。
2. 分类选“心血管”，搜索 `房颤消融`；如想限定 AI 相关内容，可改选“心血管 × AI”。
3. 可读内容先保持“全部”，避免漏掉暂未取得摘要的题录。
4. 打开目标文章，阅读原摘要；将适合讨论的文章加入晨会单。
5. 数量较少时放宽至“近 14 天”或“近 30 天”，并检查其他筛选。

12.2 准备一次晨会研讨

1. 从精选、雷达或文献库收集主题相近的 2–4 篇文献。
2. 逐篇核对研究设计、对象、终点和原摘要，整理拟讨论的问题。
3. 新版对照入口可用时，明确勾选文献，生成逐篇证据对照并核对引文。
4. 用“复制晨会汇总”分享题录与原文链接，用“导出 Markdown”保存常规清单。
5. 另用复制按钮保存证据对照与核对清单；需要完整结论时继续查阅各篇全文。

12.3 按 DOI 找回一篇旧论文

1. 进入“文献库”，选择“全部时间”。
2. 分类选“全部”，取消期刊及其他限制，输入 DOI 编号。
3. 打开阅读台，核对题名和来源；如果未命中，再到雷达扩大时间范围尝试。
4. 网站仍未收录时，直接使用期刊或 PubMed 检索；站内无结果不代表论文不存在。

12.4 如何使用这三种手册文件

文件	推荐用途	使用方式
使用说明.md	后续修改、版本管理及笔记导入	用 Markdown 阅读器打开；保持 `manual-assets` 图片文件夹与其相对位置一致
使用说明.html	浏览器阅读、通过目录跳转及打印	双击打开，样式与截图已内嵌，可离线阅读手册；跳转网站及外部原文仍需联网
使用说明.pdf	分发、打印与固定版式存档	用 PDF 阅读器打开，文字可检索，目录可跳转

需要转发含截图的 Markdown 时，建议使用完整压缩包；HTML 和 PDF 可以单独发送。后续网站按钮、布局或功能发生变化时，应更新 Markdown 正文并重新生成另两种格式。本手册中的截图不是网站实时状态证明。